

GUÍA DE APLICACIÓN CLÍNICA — Técnica S.T.O.P.

Herramienta de pausa consciente · Para uso del terapeuta en sesión

La técnica S.T.O.P. interrumpe el piloto automático emocional o cognitivo en el momento en que se detecta activación. Sus cuatro pasos permiten al paciente pasar de la reacción automática a la respuesta consciente en menos de dos minutos.

Indicaciones: Rumiación · Impulsos reactivos · Escalada emocional · Craving · Conflictos interpersonales · Estrés agudo situacional

PROTOCOLO PASO A PASO

S STOP

Para

«Detente justo donde estás. No hagas nada todavía.»

- Interrumpir físicamente la actividad o el pensamiento en curso.
- Señal interna: reconocer activación emocional o cognitiva significativa.
- **Objetivo:** romper el automatismo reactivo.

T TAKE A BREATH

Respira

«Toma una respiración consciente. Nota cómo entra el aire y cómo sale.»

- Respiración profunda y lenta; atención al movimiento del abdomen.
- Opcional: técnica 4-4-4 (inhala · retén · exhala, 4 seg cada fase).
- **Objetivo:** activar el sistema nervioso parasimpático y reducir cortisol/adrenalina.

O OBSERVE

Observa

«¿Qué está pasando dentro de ti ahora mismo? Sin juzgarlo, sin cambiarlo.»

Canal	Preguntas guía
Cuerpo	¿Dónde noto tensión? ¿Qué sensaciones físicas hay?
Emociones	¿Qué emoción está presente? ¿Intensidad (0-10)?
Pensamientos	¿Qué dice mi mente? ¿Son hechos o interpretaciones?

Postura de testigo imparcial: observar sin identificarse. Nombrar la emoción («noto que hay ansiedad»). **Objetivo:** distancia metacognitiva y defusión cognitiva.

P PROCEED

Continúa con conciencia

«¿Qué quieres hacer ahora? No la reacción automática — lo que tú eliges.»

- Retomar la actividad con mayor conciencia o elegir una acción deliberada.
- «¿Qué haría la persona que quiero ser en este momento?» (enlace ACT con valores).
- **Objetivo:** acción consciente frente a reacción automática.



P1 No puede parar — activación demasiado alta

Por qué ocurre: Con activación intensa el córtex prefrontal está inhibido y el paciente no puede «decidir parar».

Qué hacer:

- Añadir ancla física previa: «Pon los dos pies en el suelo, nota el peso. Ahora sí — para.»
- Usar una señal física externa como disparador (ej. mano en el pecho).
- Entrenar la técnica en momentos de baja activación, no en crisis.

P2 La respiración genera más ansiedad

Por qué ocurre: Frecuente en pánico o hipocondría: dirigir atención a la respiración puede disparar más activación.

Qué hacer:

- Redirigir la atención: «Solo observa que estás respirando, sin cambiar nada.»
- Sustituir por pausa sensorial externa: notar la temperatura de la mesa durante 3 segundos.
- Abreviar el paso T a una simple pausa de 2 segundos.

P3 Se pierde en los pensamientos en lugar de observarlos

Por qué ocurre: La instrucción de «observar la mente» puede convertirse en déclencheur de más rumiación (especialmente en depresión o TAG).

Qué hacer:

- Defusión cognitiva ACT: «Nótalo desde fuera. ¿Qué dice? No si es verdad — solo qué dice.»
- Limitar a 5 segundos: «Una palabra o frase es suficiente.»
- Anclar al cuerpo si la mente se dispersa: «¿Dónde sientes la emoción físicamente?»
- Fórmula de nombrado: «En lugar de 'estoy ansioso', prueba 'noto que hay ansiedad'.»

P4 El paso P siempre termina en la misma respuesta automática

Por qué ocurre: El hábito conductual es tan fuerte que vuelve a la respuesta automática aunque haya completado los cuatro pasos.

Qué hacer:

- Trabajar el paso P explícitamente en sesión, en frío: listar opciones antes de que ocurra la situación.
- Conectar con valores: «¿Qué haría la versión de ti que actúa desde lo que más te importa?»
- Introducir micro-demora conductual: «Solo espera 2 minutos antes de actuar.»

P5 Lo hace en sesión pero no lo recuerda en el momento real

Por qué ocurre: Bajo alta activación el acceso al recuerdo procedimental se bloquea; la técnica aún no está automatizada.

Qué hacer:

- Crear una tarjeta física (o fondo de pantalla) con las cuatro letras y una frase por paso.
- Establecer disparador corporal personalizado: la primera señal de activación = inicio del STOP.
- Practicar a diario en situaciones de baja intensidad (atasco, cola, aburrimiento).

P6 Le parece demasiado simple o no se cree que funcione

Por qué ocurre: Pacientes con alta capacidad intelectual o experiencias previas negativas pueden desestimar la técnica.

Qué hacer:

- Explicar el mecanismo: la activación inhibe el córtex prefrontal; parar y observar lo reactiva.
- Ofrecerla como experimento: «No te pido que creas que funciona. Pruébala 5 veces y cuéntame qué observas.»
- Normalizar efecto acumulativo: «La primera vez cambia poco. La décima vez, sí.»

RESUMEN RÁPIDO DE ADAPTACIONES

Dificultad	Adaptación clave
No puede parar	Ancla física previa + entrenar en calma
Respiración genera ansiedad	Observar sin cambiar + sustituir por pausa táctil
Se pierde en pensamientos	Defusión ACT + anclar al cuerpo + límite de tiempo
Siempre termina igual en P	Opciones en frío + conectar con valores
No lo recuerda en el momento	Tarjeta física + disparador corporal personalizado
No se cree que funcione	Explicación neurofisiológica + enfoque experimental